

Terapia par z NPD

Naiwna „symetryczna” terapia par (50/50 winy) **wzmacnia** gaslighting. Często lepiej: indywidualna dla obojga. Trzy warunki, kiedy terapia par jest skuteczna.

CZAS: 12 min Dla terapeuty i par **ŹRÓDŁO:** Lachkar (1992); Solomon (1989); Lewis (1998)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, dlaczego *symetryczna* terapia par (Gottman, EFT) bywa **iatrogenna** w NPD (sekcja 01). **2** · Poznasz mechanizm wzmacniania gaslightingu w sesji (sekcja 02). **3** · Poznasz **trzy warunki**, kiedy terapia par *może* działać (sekcja 03). **4** · Zobaczysz alternatywę: indywidualna dla obojga z koordynacją (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Terapia par z partnerem NPD wymaga terapeuty, który *rozumie* dynamikę narcystyczną. „Standardowa” terapia par (Gottman, EFT Johnson) zakłada **symetrię** — „każdy wnosi 50%”. Przy asymetrycznej dynamice nadużycia i narcyzmu ta symetria **wzmacnia gaslighting**: narcyz wykorzystuje „terapeuta przyznał, że to też twoja wina”. Lewis (1998) ostrzegł, że symetryczna terapia par z partnerem NPD może być **iatrogenna** — czyli pogarszać stan. Lachkar (1992) w *The Narcissistic/Borderline Couple* oraz Solomon (1989) w *Narcissism and Intimacy* zarysowali alternatywne podejście: *asymetryczna* terapia par, w której terapeuta nazywa wzorce wprost (idealizacja-dewaluacja, gaslighting, brak empatii) i utrzymuje granice w sesji. *Typowy iatrogenny scenariusz*: para idzie na terapię. Terapeuta stosuje EFT/Gottmana — „oboje cierpicie, pracujemy nad komunikacją”. Narcyz wraca do domu: „*terapeuta powiedział, że to też twoja wina, masz przestać mnie krytykować*”. Partnerka-nie-NPD czuje się *zdradzona* przez terapię. Po 6 miesiącach: ona w depresji, on bardziej pewny siebie. *Solomon (2002)*: terapia par w NPD wymaga **równowagi** — walidacja obojga partnerów. Narcyz też cierpi (pod fasadą), partner też cierpi (w rezultacie zachowań narcyza). EFT (Johnson) *może* działać, jeśli udaje się dotrzeć do *primarnych emocji* narcyza (lęk, wstyd pod złością/pogardą). Kluczowe: *granice w sesji* — brak dewaluacji partnera, brak gaslightingu. Realistyczne oczekiwania: zmiana jest **wolna i ograniczona**. *Warunki skuteczności*: terapia par działa *tylko*, gdy: (1) diagnoza narcyzmu jest **jawna**; (2) narcyz ma wgląd i motywację (rzadkie); (3) terapeuta umie pracować asymetrycznie. Jeśli któryś warunek niespełniony — uczciwiej polecić indywidualną.

01



Symetryczna terapia par — dlaczego iatrogenna w NPD

ZAŁOŻENIE STANDARDOWYCH METOD

Gottman, EFT: oboje wnoszą po 50%. „Każdy ma swoje wzorce, oboje cierpicie, pracujemy nad komunikacją.” Działa w *symetrycznych* parach.

CO DZIEJE SIĘ W NPD

Dynamika jest *asymetryczna*. Gaslighting, idealizacja-dewaluacja, eksploatacja. „50/50 winy” to *fałszywa* ramówka — wzmacnia narrację narcyza.

02 Mechanizm wzmacniania gaslightingu w sesji

Lewis (1998): w parach z NPD symetryczne podejście jest **iatrogenne** — czyli aktywnie *pogarsza* stan partnera-nie-NPD. Po 6 miesiącach: partner w depresji, narcyz pewny siebie („mam rację, terapeuta to potwierdził”).



ja jestem chora" **EFEKT** depresja partnera + pewność narcyza ↑

Mechanizm: narcyz **nie** słyszy „oboje pracujecie” — słyszy „terapeuta przyznał, że to twoja wina”. Symetryczna ramówka staje się *narzędziem* w arsenale gaslightingu. To dlatego doświadczeni terapeuci par odmawiają pracy z partnerem o niezdiagnozowanym (i nieleczonym) NPD.

03 Trzy warunki skuteczności terapii par z NPD

1 · JAWNA DIAGNOZA

Narcyz **uznaje** diagnozę NPD i swój wkład w problem. Bez tego dynamika nie wychodzi z gabinetu — wraca w przekładzie narcyza.

2 · WGLĄD I MOTYWACJA

Narcyz ma *insight* („widzę, że krzywdzę”) i motywację do zmiany. Bardzo **rzadkie**. Najczęściej zostaje pod presją utraty relacji.

3 · DOŚWIADCZONY TERAPEUTA

Terapeuta zna NPD i pracuje *asymetrycznie*. Nazywa wzorce wprost. Ustanawia granice w sesji. Bez tego — iatrogenne efekty.

04 Alternatywa: indywidualna dla obojga

DLA NARCYZA

TFP albo terapia schematów. 2-5 lat. *Bez* presji „naprawy” relacji. Praca z rdzeniem wstydu, splittingiem, regulacją wartości.

DLA PARTNERA

Psychoedukacja, walidacja, praca z C-PTSD, decyzja o relacji. Indywidualna terapia umożliwia *nieprzemyślaną* decyzję — niezależnie od dynamiki w sesji par.

Klucz: standardowa terapia par (Gottman, EFT) zakłada *symetrię* — w NPD ta symetria **wzmacnia gaslighting**. Lewis (1998) ostrzegł przed iatrogennymi efektami. Skuteczne podejście: *jawna diagnoza + motywacja narcyza + doświadczony terapeuta* = wszystkie trzy. Brak choć jednego z tych elementów — uczciwiej polecić indywidualną dla obojga. Solomon (1989, 2002), Lachkar (1992): asymetryczna terapia par jest możliwa, ale rzadka. Realistyczne oczekiwania: zmiana *wolna i ograniczona*. Jeśli partner-nie-NPD zostaje w relacji — niezbędna własna terapia, niezależnie od decyzji o terapii par.